

ANÁLISE DO ATAQUE DE RANSOMWARE À CHANGE HEALTHCARE (2024)

Acesso inicial, impacto nos serviços e resposta ao incidente

ESCOPO: Estudo de caso desenvolvido a partir de uma atividade proposta no âmbito do Mulher Digital. A análise examina o que ocorreu na Change Healthcare, seus impactos, os profissionais que podem ter participado da resposta, sem pretensão de realizar uma investigação técnica avançada.

Síntese executiva

O ataque à Change Healthcare mostra como um problema no controle de acesso pode alcançar muitos serviços quando ocorre em uma organização que ocupa uma posição central na cadeia de saúde. As fontes públicas indicam que credenciais comprometidas foram usadas para acessar um portal Citrix sem autenticação multifator (MFA). O acesso ocorreu em 12 de fevereiro de 2024. Em 21 de fevereiro, o grupo ALPHV/BlackCat executou o ransomware, e a UnitedHealth Group (UHG) desconectou os sistemas afetados para conter a propagação (REUTERS, 2024a; ASSOCIATED PRESS, 2024b).

O incidente atingiu simultaneamente a confidencialidade e a disponibilidade. Dados pessoais e de saúde foram exfiltrados, enquanto serviços de prescrição, autorização, faturamento, processamento de solicitações e pagamentos ficaram indisponíveis. O Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos (HHS) posteriormente consolidou o total de 192,7 milhões de pessoas afetadas, dimensão que tornou o caso a maior violação de dados de saúde registrada no país até então (HHS, 2025; REUTERS, 2025).

Com base nos dados públicos encontrados, podemos concluir que o acesso inicial não ocorreu por uma vulnerabilidade inédita do Citrix. As fontes relacionam o incidente ao uso de credenciais comprometidas em um serviço de acesso remoto sem MFA. Elas não identificam como essas credenciais foram obtidas. Por isso, phishing, exploração de uma vulnerabilidade específica ou outros métodos permanecem como possibilidades gerais, e não como causas confirmadas deste caso. A Reuters corrigiu a cobertura inicial para esclarecer esse ponto (REUTERS, 2024a).

CONCLUSÃO CENTRAL Os dados públicos mostram que o incidente foi além do bloqueio causado pelo ransomware. O caso reúne questões de gestão de identidade e acesso, segurança em camadas e dependência de um serviço central para a cadeia de saúde. Quando uma plataforma desse porte fica indisponível, os efeitos alcançam pacientes, farmácias, hospitais, clínicas e prestadores.

1. Objetivo, método e limites

O objetivo é reconstruir o caso com base em fontes públicas confiáveis, explicar o que aconteceu, como o incidente afetou a organização e por que a cibersegurança exerce impacto tão importante em serviços tecnológicos modernos. A análise utiliza conceitos como confidencialidade, integridade, disponibilidade e autenticidade; risco e vulnerabilidade; privilégio mínimo; segurança em camadas; gestão de ativos e vulnerabilidades; registros de auditoria; continuidade e backup; monitoramento; SOC; MFA; malware; ransomware; acesso não autorizado; e resposta a incidentes.

A pesquisa priorizou comunicados regulatórios, audiência pública, atualizações da empresa e dados governamentais. Essas informações foram comparadas com as reportagens da Reuters, da Associated Press e com dados da American Hospital Association (AHA). O texto separa os fatos confirmados, a análise construída a partir deles e as práticas de segurança que podem apoiar situações semelhantes.

De acordo com as fontes consultadas, foram divulgadas as empresas que participaram da resposta, mas não a relação completa das ferramentas utilizadas. Por isso, Splunk, CrowdStrike Falcon e outras ferramentas aparecem neste estudo apenas como exemplos de uso possível. Mandiant e Palo Alto Networks são citadas como participantes da resposta, sem que isso confirme quais ferramentas foram realmente utilizadas (REUTERS, 2024a).

2. Contexto e importância para outros serviços

A Change Healthcare integra a infraestrutura administrativa do setor de saúde dos Estados Unidos. Ela conecta pagadores, prestadores e farmácias para atividades como processamento de solicitações de reembolso, pagamentos, elegibilidade e prescrições. A empresa passou a integrar a Optum, do UnitedHealth Group, após a conclusão da aquisição em 2022 (WIKIPEDIA, 2026). A cobertura jornalística descreveu a empresa como responsável por cerca de metade das solicitações médicas do país e por aproximadamente 14 bilhões de transações de saúde por ano (ASSOCIATED PRESS, 2024a; REUTERS, 2024a). Nos primeiros dias do incidente, a Forbes registrou atrasos relacionados a prescrições e efeitos em algumas operações da CVS, mostrando como a interrupção alcançou rapidamente organizações que dependiam da plataforma (BOHANNON, 2024).

Essa interdependência muda a forma de observar o risco. O ativo crítico não é apenas um servidor ou banco de dados isolado, mas o serviço que sustenta fluxos financeiros e de atendimento. Quando esse serviço fica indisponível, o incidente tecnológico também afeta a continuidade das atividades, a capacidade de atendimento e a estabilidade financeira de outras organizações.

Uma pesquisa da AHA com quase mil hospitais registrou impacto financeiro em 94% dos participantes e impacto direto no atendimento em 74%. Mais de 80% relataram efeitos no fluxo de caixa. Entre os que estimaram perdas, quase 60% indicaram impacto de pelo menos US\$ 1 milhão por dia. A pesquisa não representa todas as instituições, mas ajuda a compreender a amplitude dos efeitos operacionais do incidente (AMERICAN HOSPITAL ASSOCIATION, 2024).

3. Cronologia verificada

Data	Evento	Base documental
12 fev. 2024	Credenciais comprometidas permitem acesso remoto ao portal Citrix da Change Healthcare, que não possuía MFA.	Audiência do Senado; Reuters; AP.
21 fev. 2024	O grupo ALPHV/BlackCat executa o ransomware. A UHG identifica a ameaça e desconecta os sistemas afetados.	SEC; Reuters; AP.
1–7 mar. 2024	É criado programa temporário de financiamento; serviços de prescrição eletrônica são restaurados e são anunciados marcos para pagamentos e solicitações de reembolso.	UHG.
18 mar. 2024	A restauração de software e conectividade de processamento de solicitações avança em fases, com validações antes da reconexão.	UHG.
22 abr. 2024	A UHG informa que a amostragem preliminar encontrou dados pessoais e de saúde potencialmente relacionados à parcela substancial da população; inicia suporte e monitoramento.	UHG; SEC.
1 maio 2024	O CEO Andrew Witty confirma em audiência a ausência de MFA no portal, o pagamento do resgate e a reconstrução de sistemas.	Senado dos EUA; AP.
jun.–jul. 2024	Começam notificações sobre a violação e ações regulatórias de privacidade; a apuração do universo afetado continua.	UHG; HHS; AP.
31 jul.–14 ago. 2025	O HHS registra o total final de 192,7 milhões de pessoas afetadas; a Reuters noticia a consolidação.	HHS; Reuters.

A diferença de nove dias entre o acesso inicial confirmado e a execução do ransomware chama atenção. De acordo com os dados encontrados, podemos pensar que esse período poderia ter produzido alertas sobre autenticação remota, uso incomum de credenciais ou transferência incomum de dados. As fontes não apresentam os registros técnicos necessários para saber quais alertas existiram. Essa leitura é uma possibilidade de análise, e não um fato divulgado sobre o ambiente da empresa.

4. Evidências jornalísticas

As figuras a seguir registram a identificação das fontes, o título e a data das notícias. Elas funcionam como evidência visual da pesquisa, mas não substituem a leitura integral nem as fontes primárias. Os recortes foram limitados aos cabeçalhos para evitar reprodução excessiva do conteúdo jornalístico.



Figura 1 — Reuters corrige a versão preliminar e identifica credenciais comprometidas como vetor confirmado.

Fonte: [Reuters, 30 abr. 2024](#)



Figura 2 — Associated Press destaca a ausência de autenticação multifator no servidor acessado.

Fonte: [Associated Press, 1 maio 2024](#)

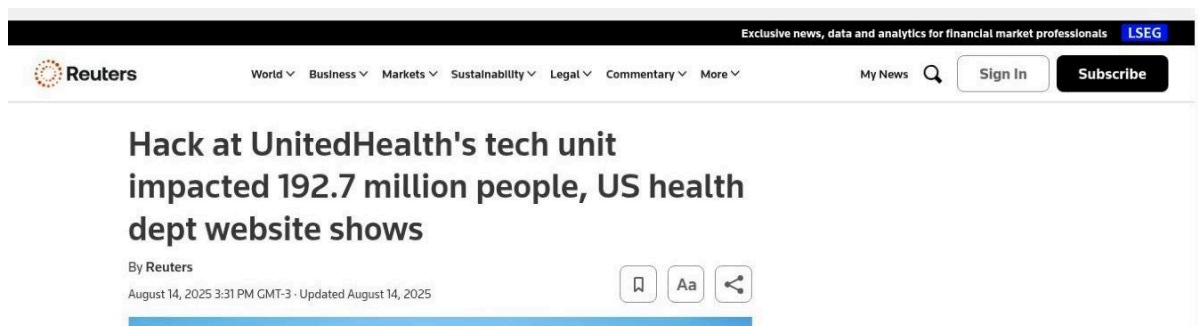


Figura 3 — Reuters registra o total consolidado de 192,7 milhões de pessoas afetadas.

Fonte: [Reuters, 14 ago. 2025](#)

5. Reconstrução técnica do ataque

5.1 Acesso inicial e ausência de MFA

O ponto de entrada confirmado foi um portal Citrix de acesso remoto. Os atacantes utilizaram credenciais válidas que haviam sido comprometidas, e o portal não exigia MFA. A MFA acrescenta uma etapa de verificação e dificulta o uso isolado de uma credencial comprometida. Nesse caso, a ausência desse controle permitiu que as credenciais fossem usadas para acessar a rede (REUTERS, 2024a; ASSOCIATED PRESS, 2024b).

Com base na gestão de contas e no controle de acesso, esse ponto também pode ser relacionado ao princípio do privilégio mínimo. Uma conta precisa ter somente os acessos necessários para sua função, com atenção especial a conexões remotas, dispositivos desconhecidos e atividades de maior risco.

As fontes consultadas confirmam o uso de credenciais comprometidas, mas não informam como elas foram obtidas. Phishing, malware, reutilização de senha ou vazamento anterior são possibilidades conhecidas, porém não foram confirmadas como causa deste incidente.

5.2 Exfiltração, ransomware e extorsão

Depois do acesso, houve retirada de dados e, em 21 de fevereiro, criptografia ou bloqueio de sistemas pelo ALPHV/BlackCat. O incidente afetou a confidencialidade e a disponibilidade: os dados foram retirados antes do bloqueio dos sistemas, o que aumentou a pressão sobre a empresa. A Change Healthcare reconheceu o pagamento de aproximadamente US\$22 milhões em bitcoin (ASSOCIATED PRESS, 2024b).

O pagamento do resgate foi uma das decisões tomadas durante a crise. Com os dados públicos encontrados, podemos concluir que esse pagamento não eliminou a necessidade de investigação, recuperação dos sistemas e comunicação com as pessoas afetadas. Ele também não garante que as cópias retiradas pelos atacantes deixem de existir. A decisão ocorreu em um cenário de forte pressão sobre serviços de saúde e fluxos financeiros.

5.3 Propagação do impacto

A UHG desconectou os ambientes da Change para reduzir a possibilidade de propagação. A medida está alinhada à etapa de contenção da resposta a incidentes, mas também deixou funções centrais indisponíveis para muitas organizações. O caso mostra como segmentação, redundância e alternativas de processamento podem ajudar a reduzir o impacto de uma interrupção desse porte.

A dependência de um provedor central amplia o impacto sobre terceiros. De acordo com os dados encontrados, podemos perceber a importância de mapear dependências, avaliar controles, definir formas de comunicação, manter alternativas operacionais e testar situações

de indisponibilidade. Esse aprendizado se relaciona à gestão de prestadores de serviço e à recuperação de dados.

6. Impacto nos princípios de segurança

Princípio	Evidência no caso	Avaliação
Confidencialidade	Exfiltração de dados pessoais e de saúde; o total final chegou a 192,7 milhões de pessoas.	Impacto amplo e confirmado.
Disponibilidade	Interrupções em prescrições, autorizações, solicitações de reembolso, pagamentos e faturamento, com efeitos em hospitais, farmácias e consultórios.	Impacto amplo e confirmado.
Integridade	As fontes consultadas confirmam que o ransomware afetou sistemas e processos, mas não registram alteração deliberada de prontuários ou resultados clínicos.	Possibilidade relacionada ao ataque; alteração clínica não confirmada.
Autenticidade	Credenciais legítimas foram usadas por agentes não autorizados, rompendo a confiança na identidade apresentada ao portal.	Impacto confirmado no mecanismo de autenticação.
Privacidade	Informações de seguro, cobrança, diagnóstico, tratamento e identificadores pessoais podem ter sido expostas, variando conforme cada pessoa.	Impacto amplo e confirmado.

O total de 192,7 milhões de pessoas afetadas não significa que todas tiveram os mesmos tipos de dados expostos. O HHS e a UHG apresentaram conjuntos possíveis de informações, e a empresa informou que não identificou acesso a prontuários médicos completos nem uso indevido até suas atualizações. Com base nesses dados, o texto utiliza a expressão “dados potencialmente envolvidos” sem atribuir o mesmo conteúdo a todas as pessoas (UNITEDHEALTH GROUP, 2024b; HHS, 2025).

A proteção desses dados também passou a fazer parte da resposta institucional. Em 13 de março, a CNN informou que o Escritório de Direitos Civis do HHS abriu uma investigação para verificar se informações de saúde protegidas haviam sido comprometidas e se as regras de privacidade haviam sido cumpridas (CNN, 2024a).

7. Avaliação de risco e pontos de atenção nos controles

Na avaliação de risco, a ameaça era um grupo de ransomware capaz de retirar dados e interromper serviços. A vulnerabilidade observada foi a ausência de MFA em um acesso remoto. Entre os ativos estavam sistemas de transações, contas de acesso, dados de saúde e serviços importantes para várias organizações. As consequências incluíram prejuízo financeiro, exposição de dados, atrasos nas atividades, pressão sobre o atendimento e efeitos na confiança.

Controle	Leitura do caso	Reforço prioritário
CIS 5 e 6 — contas e acesso	Portal remoto sem MFA; uso indevido de credencial válida.	MFA, privilégio mínimo e revisão periódica de contas e acessos.
CIS 8 e 13 — logs e monitoramento	Janela de nove dias entre o acesso e o ransomware; as fontes não detalham os alertas gerados nesse período.	Reunir logs em um SIEM, criar alertas de acesso incomum e manter os registros pelo período necessário.
CIS 11 — recuperação	Reconstrução extensa e indisponibilidade prolongada.	Backups protegidos e offline, testes de restauração e procedimentos de recuperação.
CIS 12 — infraestrutura de rede	Desconexão ampla para conter o incidente.	Segmentação de rede, separação de áreas administrativas e limitação do acesso remoto.
CIS 15 — fornecedores	Dependência de uma única empresa intermediária.	Avaliação periódica de fornecedores, requisitos de segurança, alternativas operacionais e exercícios conjuntos.
CIS 17 — resposta a incidentes	A resposta mobilizou equipes e autoridades, e os serviços foram restaurados por etapas.	Planos de resposta, papéis claros, exercícios, comunicação e revisão pós-incidente.

Entre os pontos que mais chamam atenção está a ausência de MFA no acesso remoto. Esse controle acrescenta uma etapa de verificação. Ao mesmo tempo, os dados encontrados mostram que o incidente não pode ser explicado por uma única configuração. A segurança em camadas combina controle de acesso, monitoramento, segmentação, proteção contra malware e recuperação de dados para reduzir a possibilidade de um único problema alcançar todo o ambiente.

8. Resposta ao incidente: o que foi confirmado

O ciclo de resposta a incidentes — identificar, classificar, conter, recuperar, comunicar, documentar e aprender — ajuda a organizar as medidas relatadas pelas fontes. Com os dados públicos encontrados, podemos acompanhar as ações externas confirmadas e compreender como diferentes equipes participaram da resposta.

Etapas	Ação observada	Grau de confirmação
Identificação e contenção	A UHG identificou uma ameaça em 21 de fevereiro, isolou os sistemas afetados e interrompeu a conectividade com os data centers da Change para reduzir risco de propagação.	Confirmado por SEC e depoimento público.
Investigação e coordenação	Foram acionados FBI, autoridades e especialistas externos; Reuters registrou participação de equipes da Mandiant e Palo Alto Networks, além de especialistas do Google, Microsoft, Cisco e Amazon.	Organizações confirmadas; produtos não divulgados.
Erradicação e recuperação	A empresa informou ter reconstruído a plataforma a partir do zero e realizou restauração gradual de prescrição, pagamentos e processamento de solicitações de reembolso, com validações antes da reconexão.	Confirmado por AP e UHG.
Continuidade financeira	Foi criado programa temporário de financiamento e foram oferecidos adiantamentos/financiamentos sem juros a prestadores afetados.	Confirmado por UHG e SEC.
Comunicação e privacidade	A UHG publicou atualizações, abriu central de atendimento, ofereceu dois anos de monitoramento de crédito e proteção contra roubo de identidade e iniciou notificações.	Confirmado por UHG, HHS e AP.
Monitoramento posterior	A empresa relatou o monitoramento de possíveis divulgações dos dados e a análise de amostras dos arquivos retirados.	Confirmado pela UHG; as fontes não detalham todo o processo técnico.
Pagamento de resgate	O CEO confirmou pagamento aproximado de US\$22 milhões.	Confirmado em audiência pela AP.

A decisão de desconectar rapidamente o ambiente está alinhada à prioridade de contenção. Com base nos dados públicos encontrados, podemos concluir que essa ação reduziu a possibilidade de propagação e permitiu restaurar os serviços por etapas. A recuperação prolongada também mostra a dificuldade de manter as atividades quando uma plataforma central fica indisponível. Nesse processo, analistas de SOC podem acompanhar alertas e logs; equipes de resposta a incidentes investigam e contém; profissionais de infraestrutura apoiam a recuperação; e áreas executivas, jurídicas e de comunicação coordenam decisões e informações.

Em 18 de março, a CNN informou que 95% das solicitações de reembolso de seguros de saúde já estavam sendo processadas e que 99% dos serviços da rede de farmácias haviam retornado. Ao mesmo tempo, pequenas clínicas e prestadores rurais ainda relatavam

necessidade de apoio financeiro. Esses dados ajudam a perceber que a restauração técnica pode avançar antes que os efeitos operacionais terminem para todas as organizações (CNN, 2024b).

Os custos ajudam a compreender a dimensão financeira do incidente. No resultado do primeiro trimestre de 2024, a UHG informou US\$ 872 milhões em efeitos relacionados ao ataque e mais de US\$ 6 bilhões em adiantamentos e empréstimos sem juros a prestadores até meados de abril (UNITEDHEALTH GROUP, 2024c). Esses valores mostram os efeitos financeiros da crise e as medidas de apoio adotadas pela empresa.

9. Práticas que podem apoiar uma resposta semelhante

As fontes públicas apresentam as principais ações de resposta, mas não detalham todos os procedimentos técnicos. Com base nas etapas de gestão de incidentes, as práticas a seguir poderiam apoiar uma organização em uma situação semelhante:

1. Preservar logs, registros e outras evidências úteis para a investigação e para a cooperação com as autoridades.
2. Bloquear contas comprometidas, alterar as credenciais relacionadas e exigir MFA antes de permitir novos acessos.
3. Identificar os ativos afetados por meio dos logs e do monitoramento de contas, computadores, servidores e rede.
4. Isolar os ativos afetados sem apagar evidências e realizar a reconexão somente depois das verificações de segurança.
5. Recuperar os sistemas críticos, restaurar os dados a partir de backups testados e verificar a integridade antes da reconexão.
6. Manter alternativas para prescrições, faturamento, autorizações, solicitações de reembolso e pagamentos, com prioridade para os serviços de maior impacto no atendimento.
7. Manter a direção, a área jurídica, os órgãos responsáveis, os clientes, os prestadores e as pessoas afetadas informados com mensagens claras e atualizações regulares.
8. Registrar as decisões tomadas, revisar o incidente e acompanhar as medidas de reforço com responsáveis e prazos definidos.

10. Ferramentas: confirmadas e possíveis

As fontes confirmam as equipes e empresas envolvidas, mas não apresentam a relação completa das ferramentas utilizadas. Por isso, a tabela separa a participação confirmada das ferramentas que poderiam apoiar uma resposta semelhante.

Ferramenta/equipe	Função	Status no caso
Mandiant	Empresa/equipe de resposta e investigação	Participação confirmada; ferramenta ou módulo não divulgado.

Ferramenta/equipe	Função	Status no caso
Palo Alto Networks	Empresa/equipe de cibersegurança	Participação confirmada; a ferramenta específica utilizada não foi divulgada.
Google, Microsoft, Cisco e Amazon	Especialistas técnicos e provedores do ecossistema	Apoio citado no depoimento; as ferramentas utilizadas não foram detalhadas.
Splunk	SIEM para reunir e analisar logs	Poderia ajudar a identificar acessos incomuns e analisar os logs; uso não confirmado.
CrowdStrike Falcon	Monitoramento e proteção de computadores e servidores	Poderia ajudar a isolar equipamentos afetados, identificar a execução do malware e apoiar a investigação; uso não confirmado.
SOC e SIEM	Monitoramento e análise de alertas	Poderiam apoiar a identificação de acessos suspeitos e a organização dos registros; uso específico não confirmado.
Firewall, IDS e IPS	Controle e monitoramento de rede	Poderiam limitar acessos entre áreas da rede, identificar tráfego incomum e apoiar a segmentação.
Gestão de vulnerabilidades	Identificação e acompanhamento de vulnerabilidades	Poderia identificar serviços remotos, configurações inseguras e exposições; trabalha em conjunto com a revisão de contas e de MFA.
Backup e recuperação de dados	Recuperação de dados e continuidade	Ajuda a restaurar dados e serviços quando as cópias são protegidas e testadas.

As fontes confirmam a participação de empresas e especialistas, mas não informam todas as ferramentas utilizadas. Por isso, Splunk e CrowdStrike Falcon são apresentadas como exemplos de ferramentas que poderiam apoiar uma resposta semelhante.

11. Plano de reforço da proteção

O plano de reforço pode combinar pessoas, processos e tecnologia, começando pelos controles que ajudam a reduzir o risco com mais rapidez. A ordem abaixo considera o tempo necessário e a importância de cada ação.

Prazo	Objetivo	Ações
0–30 dias	Proteger o acesso remoto	MFA em todo acesso remoto e administrativo; desativação de contas inativas; alteração de credenciais comprometidas; revisão de privilégios; inventário dos portais expostos e verificação das formas de autenticação.
0–60 dias	Aumentar detecção e contenção	Reunir logs no SIEM, criar alertas de acesso incomum, monitorar ativos e segmentar sistemas críticos.
30–90 dias	Garantir recuperação	Backups protegidos e offline; testes de restauração; procedimentos de recuperação para solicitações de reembolso, prescrições e pagamentos; verificação da integridade antes da reconexão.
60–180 dias	Reduzir o impacto sobre outros serviços	Privilégio mínimo, segmentação de rede, criptografia, gestão contínua de vulnerabilidades, alternativas para serviços de fornecedores e exercícios com terceiros.
Contínuo	Sustentar governança	SOC com indicadores de acompanhamento, revisão periódica de acessos, treinamento, testes autorizados de phishing, avaliação de fornecedores, simulações de ransomware e acompanhamento dos riscos pela direção.

11.1 Indicadores de acompanhamento

- Cobertura de MFA: percentual de contas remotas e administrativas protegidas.
- Cobertura de logs: percentual de ativos críticos enviando registros íntegros ao SIEM.
- Tempo médio para detectar e conter atividades suspeitas em contas, computadores, servidores e rede.
- Percentual de contas com privilégio revisado no prazo e número de contas inativas removidas.
- Taxa de sucesso dos testes de restauração e tempo necessário para recuperar os serviços.

- Percentual de fornecedores críticos avaliados e com plano alternativo testado.
- Quantidade de ações do pós-incidente concluídas dentro do prazo acordado.

12. Lições aprendidas

O primeiro aprendizado é que os controles básicos continuam importantes. MFA, gestão de contas, logs e segmentação trabalham em conjunto. O caso também mostra o valor da segurança em camadas: se uma credencial for comprometida, outros controles podem ajudar a impedir, identificar ou limitar o acesso não autorizado.

Outro aprendizado está relacionado à disponibilidade, especialmente na área da saúde. Os efeitos não ficaram restritos à perda financeira, porque processos administrativos também sustentam prescrições, atendimento e continuidade das organizações. O caso ainda reforça a importância de incluir fornecedores críticos no planejamento de incidentes e de manter alternativas para serviços dos quais muitas organizações dependem.

Por fim, o caso mostra a importância de acompanhar as informações com cuidado, porque as versões iniciais podem mudar. Em maio de 2024, a CNN registrou uma estimativa inicial de cerca de um terço da população dos Estados Unidos com dados possivelmente envolvidos. O total de 192,7 milhões foi consolidado depois pelo HHS. A diferença entre esses dois momentos mostra por que uma análise precisa separar fatos, estimativas e recomendações, além de atualizar os números quando surgem informações mais completas (CNN, 2024c; HHS, 2025). A mesma atenção vale para o acesso inicial: “vulnerabilidade do Citrix” e “portal Citrix sem MFA acessado com credenciais comprometidas” levam a compreensões diferentes sobre as medidas de proteção relacionadas.

Conclusão

Com base nas evidências públicas encontradas, podemos concluir que o acesso inicial ocorreu com credenciais comprometidas em um portal remoto sem MFA. O ALPHV/BlackCat usou esse acesso para retirar dados e interromper serviços. A dimensão do impacto também está relacionada à posição central da Change Healthcare e à dependência de muitas organizações em relação aos seus serviços.

A resposta incluiu o isolamento dos ambientes afetados, a participação de especialistas, a cooperação com autoridades, a recuperação gradual dos serviços, o apoio financeiro e as notificações. O caso reforça a importância de combinar resposta, prevenção e continuidade. Entre as medidas que podem apoiar essa proteção estão MFA, privilégio mínimo, inventário de ativos, monitoramento com SIEM, segmentação, backups testados, gestão de fornecedores e aprendizado pós-incidente.

Para quem está começando a compreender a cibersegurança, este caso mostra de forma concreta como os controles básicos atuam em conjunto. MFA, privilégio mínimo, monitoramento, segurança em camadas e backups testados não funcionam de forma isolada. Quando um controle apresenta um problema, os demais podem ajudar a identificar, conter e reduzir o impacto.

Referências Bibliográficas

AMERICAN HOSPITAL ASSOCIATION. AHA survey: Change Healthcare cyberattack significantly disrupts patient care, hospitals' finances. Chicago, 15 mar. 2024. Disponível em: <https://www.aha.org/2024-03-15-aha-survey-change-healthcare-cyberattack-significantly-disrupts-patient-care-hospitals-finances>. Acesso em: 22 ago. 2026.

ASSOCIATED PRESS. Cyberattack on health insurance IT giant continues to disrupt pharmacies and hospitals. AP News, 29 fev. 2024. Disponível em: <https://apnews.com/article/change-cyberattack-hospitals-pharmacy-alphv-unitedhealthcare-521347eb9e8490dad695a7824ed11c41>. Acesso em: 22 ago. 2026.

ASSOCIATED PRESS. Change Healthcare cyberattack was due to a lack of multifactor authentication, UnitedHealth CEO says. AP News, 1 maio 2024. Disponível em: <https://apnews.com/article/change-healthcare-cyberattack-unitedhealth-senate-9e2fff70ce4f93566043210bdd347a1f>. Acesso em: 22 ago. 2026.

BOHANNON, Molly. Change Healthcare cyberattack disrupts services nationwide—here's what to know. Forbes, 23 fev. 2024. Disponível em: <https://www.forbes.com/sites/mollybohannon/2024/02/23/change-healthcare-cyberattack-disrupts-services-nationwide-heres-what-to-know/>. Acesso em: 23 ago. 2026.

CNN. Feds investigating whether hacked health care giant complied with law protecting patient data. CNN, 13 mar. 2024a. Disponível em: <https://edition.cnn.com/2024/03/13/politics/feds-investigating-whether-hacked-health-care-giant-complied-with-law-protecting-patient-data>. Acesso em: 23 ago. 2026.

CNN. Hacked health care giant makes progress in recovery, but concerns for small clinics remain. CNN, 18 mar. 2024b. Disponível em: <https://edition.cnn.com/2024/03/18/tech/health-insurance-billing-system-cyberattack>. Acesso em: 23 ago. 2026.

CNN. A third of Americans could have had data stolen in big health care hack. CNN, 1 maio 2024c. Disponível em: <https://edition.cnn.com/2024/05/01/politics/data-stolen-healthcare-hack>. Acesso em: 23 ago. 2026.

CNN BRASIL. Apagão cibernético impacta serviços de saúde brasileiros; entenda. São Paulo, 19 jul. 2024. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/apagao-cibernetico-global-impacta-servicos-de-saude-brasileiros-entenda/>. Acesso em: 23 ago. 2026.

REUTERS. UnitedHealth hackers used stolen login credentials to break in, CEO says. Reuters, 30 abr. 2024a. Disponível em: <https://www.reuters.com/technology/cybersecurity/unitedhealth-hackers-took-advantage-citrix-vulnerability-break-ceo-says-2024-04-29/>. Acesso em: 22 ago. 2026.

REUTERS. Hack at UnitedHealth's tech unit impacted 192.7 million people, US health dept website shows. Reuters, 14 ago. 2025. Disponível em: <https://www.reuters.com/business/hack-unitedhealths-tech-unit-impacted-1927-million-people-us-health-dept-website-2025-08-14/>. Acesso em: 22 ago. 2026.

UNITEDHEALTH GROUP. UnitedHealth Group update on Change Healthcare cyberattack. Minnetonka, 7 mar. 2024a. Disponível em: <https://www.unitedhealthgroup.com/newsroom/2024/2024-03-07-uhg-update-change-healthcare-cyberattack.html>. Acesso em: 22 ago. 2026.

UNITEDHEALTH GROUP. UnitedHealth Group cyberattack status update. Minnetonka, 18 mar. 2024b. Disponível em: <https://www.unitedhealthgroup.com/newsroom/2024/2024-03-18-uhg-cyberattack-status-update.html>. Acesso em: 22 ago. 2026.

UNITEDHEALTH GROUP. UnitedHealth Group updates on Change Healthcare cyberattack. Minnetonka, 22 abr. 2024c. Disponível em: <https://www.unitedhealthgroup.com/newsroom/2024/2024-04-22-uhg-updates-on-changehealthcare-cyberattack.html>. Acesso em: 22 ago. 2026.

UNITEDHEALTH GROUP. UnitedHealth Group reports first quarter 2024 results. Form 8-K, Exhibit 99.1. Washington, DC: U.S. Securities and Exchange Commission, 16 abr. 2024d. Disponível em: <https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/731766/000073176624000146/a2024q1exhibit991.htm>. Acesso em: 22 ago. 2026.

UNITED STATES. Department of Health and Human Services. Change Healthcare cybersecurity incident frequently asked questions. Washington, DC, atualizado em 13 ago. 2025. Disponível em: <https://www.hhs.gov/hipaa/for-professionals/special-topics/change-healthcare-cybersecurity-incident-frequently-asked-questions/index.html>. Acesso em: 22 ago. 2026.

UNITED STATES. Securities and Exchange Commission. UnitedHealth Group Incorporated: Form 8-K — cybersecurity incident. Washington, DC, 22 fev. 2024. Disponível em: <https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/731766/000073176624000045/unh-20240221.htm>. Acesso em: 22 ago. 2026.

UNITED STATES. Senate Committee on Finance. Hacking America's Health Care: assessing the Change Healthcare cyber attack and what's next. Washington, DC, 1 maio 2024. Disponível em: <https://www.finance.senate.gov/hearings/hacking-americas-health-care-assessing-the-change-healthcare-cyber-attack-and-whats-next>. Acesso em: 22 ago. 2026

WIKIPEDIA. Change Healthcare. [S. l.], 2026. Disponível em: https://en.wikipedia.org/wiki/Change_Healthcare. Acesso em: 23 ago. 2026.